

27 - 03-LES DOULEURS EN UROLOGIE - Pr Lakmichi

(0:00 - 0:28)

Les douleurs en urologie Les douleurs en urologie constituent un motif de consultation très fréquent. Ce sont des douleurs qui peuvent concerner le haut appareil urinaire, en l'occurrence le rein ou le fer, ou bien le bas appareil urinaire, à savoir la vessie, le rêve, l'erge ou la tête de bourse. Ces douleurs peuvent être aiguës ou chroniques.

(0:29 - 1:05)

Souvent, elles sont associées à des signes urinaires orientant vers l'origine, et elles ont une grande valeur pour orienter le génocide. On commence d'abord par les douleurs du haut appareil urinaire. Le maître symptôme en matière de douleurs du haut appareil urinaire reste, sans équivoque, les coliques néphritiques, ou la colique néphrosique.

(1:07 - 1:58)

C'est un syndrome douloureux lombo-abdominal aiguë, résultant en fait de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire, en amont d'une obstruction. Donc, en refort de cette définition, le caractère lombo-abdominal, l'effet du siège anatomique du rein ou du fer, l'autre caractéristique importante, c'est que c'est une douleur qui est aiguë. L'autre élément clé de cette définition, c'est que c'est une douleur qui résume d'un obstacle.

(2:00 - 3:11)

Un obstacle sur le haut appareil urinaire qui va causer une élévation importante de la pression en amont de cet obstacle, causant donc une distanciation très importante des cavités urinaires en amont de cet obstacle, et donc la compression du parenchyme rénal et de la capsule rénale, c'est-à-dire le récepteur de la douleur, et par conséquent, la douleur s'exprime. Cependant, cette colique néphritique, cette douleur, ne préjugeant rien de la nature ni du siège de l'obstacle. C'est-à-dire, on peut avoir des obstacles plusieurs étiologies, nous allons voir, et le siège de l'obstacle peut varier, de la tige pyélique, puis de la jonction pyélo-urétérale, le long de l'hydronéphrose, jusqu'au méso-urétéro.

(3:13 - 3:57)

Toutes ces localisations anatomiques peuvent être sièges de l'obstacle, et quelque soit ce qu'il y ait, va se manifester par le même tableau clinique qui est la colique. Dans plus de trois quarts des cas, jusqu'à 80% des cas des coliques néphritiques sont liés à un calcul urinaire. Donc la pathologie lithiasique constitue un élément important, qui constitue presque la majorité des causes responsables de la colique néphritique.

(3:58 - 7:10)

La forme simple est fréquente, on ne peut concevoir la forme simple que lorsqu'on définit la forme compliquée, nous allons voir par la suite. Tout d'abord, en matière de colique néphritique, la posture du patient, comme c'est assez caricaturalement mentionné sur ce schéma, il est, c'est une position qui est fléchie, avec les mains posées au niveau de la fosse lambert, et avec un patient qui ne trouve pas de position antalgique, c'est une douleur qui irradie en fait au long de l'abdomen, jusqu'à les plis inguinaux, jusqu'à les organes génitaux externes, et le patient malheureusement ne trouve pas de position antalgique, à l'opposé de certaines douleurs, je fais allusion ici à la douleur d'origine pancréatique, où le patient se trouve fléchi pour réduire la tension abdominale sur le pancréas, et la position qu'on décrit comme chaîne de fusil, c'est une position antalgique en matière de douleur pancréatique, ici en matière de colique néphritique, il n'y a pas de position antalgique en fait, c'est parce qu'il y a une mise en tension qui est très très importante de qualité rénale, et n'importe quelle soit la position du patient, la pression ne change pas, et c'est une pression qui est très élevée, et donc qui cause cette douleur, qui ne s'arrête pas, et qui n'ouvre plus par paroxysme. Les caractéristiques de la douleur, il y a 5 caractéristiques, un début qui est brutal, nous l'avons vu au cours de l'introduction, et de la définition, le siège bien entendu lombaire, le plus souvent unilatéral, exceptionnellement unilatéral, les douleurs irradiées, comme on l'a dit, de l'angle de l'inférieur vers l'adhésif, le périmé et les organismes de l'extérieur, évolution paroxystique, alors la définition de l'évolution paroxystique, c'est à dire, par les crises, il y aura des sommets, des pics douloureux, entrecoupés par des épisodes, plus ou moins de rémission, sur un fond douloureux, et la dernière caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de pression intérieure, il y a aussi d'autres signes, qui peuvent accompagner la colline critique, et qui peuvent orienter, non seulement vers l'origine urologique de la douleur, mais aussi vers l'étiologie de cette douleur.

(7:11 - 11:11)

En l'occurrence, les troubles émotionnels, en particulier la prolacturie et la maturité, l'agitation, qui peut être causée par une douleur atroce, l'onglement souffert se trouve agité, onctueux, il peut y avoir des vomissements, des nausées, voire même de la syndrome tuberculique. Les signes physiques, l'examen clinique, il faut chercher un contact lambert, donc, contact lambert à reins qui est augmenté de volume, et parmi les causes des gros reins, ce sont les obstacles, qui ont été mentionnés sur le chapitre de Roram, un tympanisme, et là, l'examen physique, trouve tout son importance, d'abord pour confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une colline critique, l'examen avec un examen des fausses lambert, qui se trouve très très sensible, c'est un patient, on se retrouve devant un patient, généralement qui est difficile à examiner, il se fait difficilement laisser examiner, et la dernière étape, l'examen physique, c'est bien entendu le toucher pelvien, les toucher rectal, les toucher vaginal chez la femme, les toucher rectal chez l'homme, les toucher pelvien, qui peuvent donner des enseignements très très importants, on les rencontre vers la cause, de cette colline critique, je donne l'exemple, du cancer du col du BRH chez la femme, entre eux, donc un stade avancé, diagnostiqué par un toucher pelvien au cancer du col, qui comprime les méas urétéraux, et la partie terminale de l'urtère pelvienne, les toucher rectal chez l'homme, on peut déceler, un cancer de la prostate, lequel cancer de la

prostate, qui envahit aussi les méas urétéraux, et peuvent causer, une urétérolite dans les progénements, en expliquant les collines critiques, mais ceci dit que, la cause la plus, la majeure partie, des histiologies en matière, de collines critiques, c'est la pathologie diastécomanique, donc les histiologies, on les a un petit peu survolé, mais là sur cette diapositive, ils sont, mis de façon méthodique, de façon claire, il y a des causes intra-luminales, il y a des causes, c'est à dire au sein de la lumière, de la voie sétrice, des causes pariétales, c'est à dire intéressantes, la paroi, des voies urinaires, et des causes extra-luminales, c'est à dire en dehors de la lumière, de la paroi, de la voie sétrice, c'est à dire des tumeurs, des adénopathies, des collines critiques. Alors les signes de gravité, donc à rechercher systématiquement, pourquoi, il faudrait, connaître ces signes de gravité, parce qu'en fait ce sont des signes, imposant tout simplement, une hospitalisation des patients, dans un milieu spécialisé, et une prise en charge, adéquate, sous peine, de laisser les patients, à des complications, qui peuvent éventuellement, engager son pronostic vital.

(11:13 - 23:38)

Alors le premier signe de gravité, c'est la fièvre, la fièvre, va nous orienter, vers une tumeur, dans ce cas, une tumeur, qui se compose aussi, et donc, comme tout autre signe de gravité, il impose l'hospitalisation, avec un drainage, de la voie extraitrice, que ce soit par voie étrograde, par mise en place, d'un centre latéral, très simple, de feu ou de bougie, entre parenthèses, pour drainer la voie extraitrice, pour éviter le risque sceptique, bien entendu, avec une couverture antibiotique. Le deuxième signe de gravité, c'est l'anurie, c'est l'anurie obstructive, et cette anurie, qui est définie, généralement, par, une durée, qui est inférieure, à 200 cc, par 24 heures, cette anurie peut être, expliquée par une obstruction, sur un, unique, anatomique, ou fonctionnelle, anatomique, c'est-à-dire, le rein contralatéral, est absent, que ce soit, des, agénésies, où, le patient est, ayant eu, une néphrectomie, dans ses antécédents, donc le patient, avec un rein unique, anatomique, ou bien fonctionnel, donc le rein, est, il est bien présent, mais il n'est pas fonctionnel, il n'est détruit, par une, cause, autre, que, le, présentation, et donc, on est devant, un, tableau, d'instruction rénale, et une, obstructive, imposant, donc, l'hospitalisation, et un, drainage, de la poitrine, qui sont les neurones, l'état de mal néphrectique, la troisième, donc, le troisième, signe de gravité, qui est, définie, par, en fait, une résistance, au traitement, antalgique, visuel, et proprement, conduit, en dernier lieu, les signes, péritoneaux, ces signes, péritoneaux, à savoir, le tympanisme, la syndrome, suboccusique, peut orienter, vers une rupture, de la voie, excrétrice, et donc, cette rupture, de la voie, excrétrice, résultant, d'une mise, en tension, excessivement, importante, au niveau, de la voie, excrétrice, et donc, cette rupture, donc, peut survenir, soit, au niveau, de la jonction, périurale, ou bien, au niveau, de la zone, du fournique, la zone, du fournique, appelée ainsi, c'est, la zone, du pouvoir, s'insérer, à la voie, excrétrice, au niveau, de la panchine, rénale, elle utilise, une zone, qui est, un peu, sourde, et c'est là, le plus souvent, où il y a, rupture, de la voie, excrétrice, ce qu'on appelle, rupture, du fournique, c'est donc, qu'il y a, une phase, en rétro-périurale, et peut, éventuellement, irriter, le périodon, et le patient, va, par conséquent, ressentir, des signes, péridoniaux, généralement, et ce sont, les signes, de la gravité, apposant,

l'hospitalisation, à un rénale, de proximité. Les examens, complémentaires, en matière, de polyclinographie, tout d'abord, on trouve, en première ligne, le couple, échographie, rénale, ou échographie, vésicoprostatique, et rénale, chez l'homme, et, rénale, bien, chez la femme, l'arme urinaire, sans préparation, alors c'est, deux examens, complémentaires, à eux seuls, peuvent, à eux seuls, peuvent nous donner, donc, la cause, de l'obstacle, dans plus de 90%, des cas, bien que, en échographie, rénale, le signe, le plus important, qui va, nous orienter, dans une, polygnostique, avec, un signe, indirect, de l'obstacle, qui est, l'hydronefroze, donc, l'échographie, va, objectiver, cette dilatation, de la voie urinaire, éventuellement, il va, nous, diagnostiquer, la présence, de calculs, enclavés, au niveau, de la jonction, qui est l'urétérale, ou bien, un calcul enclavé, au niveau, de la jonction, urétéro-vésicale, cependant, l'ureterre, quand il n'est pas, dilaté, il n'est pas visible, à l'échographie, c'est la première des choses, deuxièmement, généralement, les calculs, de moins, de 4 millimètres, ne sont pas visibles, à l'échographie, visuel, le dernier, examen, qui est, l'examen, très performant, qui est, le scanner, dominopélien, non injecté, c'est un scanner, qui va, nous permettre, de mettre, en évidence, des calculs, qui sont, donc, invisibles, aux examens, précédents, à savoir, l'échographie, et, l'ASP, alors, le scanner, dominopélien, non injecté, va, nous diagnostiquer, des calculs, quels que soient, leurs principes, et, quels que soient, leurs étiologies, et, leurs causes, les autres douleurs lambertes, parce que, en fait, il n'y a pas, que, la colique névrotique, souveinaire, à un obstacle, sur la voie accétrice, mais, on peut, avoir d'autres, causes, d'autres types, de douleurs lambertes, à savoir, la douleur, du reflux, visco-rénal, c'est pas, uniquement, des étiologies, de la douleur, mais, en fait, des, des tableaux, selon l'intensité, de cette douleur, l'intensité, la plus, la plus importante, bien entendu, c'est la colique névrotique, en dehors, des coliques névrotiques, on parlera, de l'embalgie, tout simple, l'embalgie, c'est à dire, douleurs lambertes, de cause, urologique, on trouve, la douleur, du reflux, visco-rénal, qui est une douleur, qui est brève, survenant, au cours, de l'admission, et, c'est une douleur, qui est, généralement, qui passe, généralement, de façon, inaperçue, et peut être, méconnue, par le, les praticiens, par le patient, et, d'où, l'intérêt, d'une analyse, finie, de la signologie, par, une anamnèse, assez, précise, et détaillée, la, deuxième tableau, c'est, le tableau, de la pyramide, frite, aiguë, simple, alors, la pyramide, frite, aiguë, simple, c'est, en fait, de l'embalgie, un type, de pesanteur, donc, carrément, de douleurs lambertes, sont moins, beaucoup, moins intenses, que la colonie, mais, c'est une douleur, quand même, très gênante, et, qui se trouve, qui, donc, survient, pardon, qui survient, dans un tableau, de fièvre, 38, 30 mètres de hauteur, l'autre tableau, c'est la douleur, en rapport avec, une tumeur rénale, c'est beaucoup plus, une douleur à titre, de pesanteur, qu'autre chose, douleur, du traumatisme, rénal, c'est une douleur, qui est, très importante, survenant, dans le contexte, bien entendu, du traumatisme, le traumatisme, se vend vers, un accident, de la voie publique, une chute, d'échafaudage, un rix, etc., donc, et, bien entendu, le tableau, il est, très, très parlant, avec, généralement, un point d'impact, au niveau, de la fausse lambert, et, donc, douleur, en rapport, avec, un infarctus, rénal, derrière, le tableau, clinique, c'est douleur, qui est, en fait, c'est une douleur, qui est sourde, et, survient, dans un contexte, des patients, artéritiques, avec, une comorbidité, cardiovasculaire, importante, douleur, du bas appareil, urinaire, on trouve, d'abord, douleur, d'origine, viscale, alors, douleur, d'origine, viscale, on trouve, en premier lieu, les rétentions, et, du rime, alors,

cette rétention, et, du rime, c'est une douleur, qui est siège, qui siège, bien entendu, au niveau, du siège, anatomique, de l'organe, au niveau, hypogastrique, c'est une douleur, qui est, violente, avec, une, impossibilité, d'uriner, l'examen clinique, trouve, bien entendu, une masse, hypogastrique, arrondie, et, mate, à l'attribution, en rapport, avec le globe, visical, avec une visi, qui est, trop, trop pleine, cette masse, hypogastrique, arrondie, avec, une convexité, supérieure, avec, un pôle, interne, de cette masse, qui, plonge, dans, la, cavité, pélvée, bien entendu, cette rétention, aiguë, d'urine, peut être, secondaire, souvent, un obstacle, sous, visical, à savoir, l'origine, prostatique, ou, urétrale, origine, prostatique, la première, pose, c'est peut être, fibéline, de la prostate, deuxièmement, le cancer, de la prostate, et, lorsqu'il s'agit, de l'urètre, c'est, la première, pose, de, sténose, de l'urètre, généralement, une urétrite, post-inflammatoire, laissant, des séquelles, causant, une sténose, de l'urètre, peut, exposer, une rétention, de l'urine, ou bien, un calcul, enclavé, au niveau, du pôle, visical, ou, de l'urètre, tout cela, représente, les idéologies, de, la rétention, individuelle, toujours, les douleurs, d'origine, visicale, on trouve, les cystiques, qui sont responsables, du niveau, de cystalgie, c'est une douleur, de siège, hypogastrique, toujours, mais, cette fois-ci, à titre, pesanteur, associé, à des, brûlures, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, les, Donc aigus ce sont les douleurs du survenu brutal, le patient accuse ses douleurs depuis quelques heures et il vient vous consulter en urgence.

(23:39 - 24:44)

A l'opposé, une douleur chronique qui dure peut-être plusieurs semaines voire plusieurs mois. Alors dans un contexte aigu, on est devant deux situations, soit que le patient est apirétique, généralement âgé en 13 et 18 ans, c'est le plus souvent un tableau qui oriente vers une torsion du cordon spermatique. A l'examen, le patient il a une douleur très importante au niveau de la région scrotal, au niveau de la bourse intéressée, avec un testicule qui est légèrement surélevé par rapport à sa position anatomique normale et avec un peu de chance, si le patient vous laisse bien sûr l'examiner, on peut palper des spires de torsion au niveau du cordon spermatique.

(24:45 - 25:43)

Le diagnostic de la torsion du cordon spermatique est un diagnostic le plus souvent clinique et les examens complémentaires ne doivent en aucun cas retarder la prise en charge qui est une prise en charge chirurgicale. La deuxième cause de la douleur scrotal aiguë, mais cette fois-ci dans un contexte fébrile, ce sont les orchies épidémiques, c'est-à-dire les inflammations d'origine bactérienne du tissu bulle ou bien du tissu bulle avec les annexes, à savoir l'épidémie. Ça, dans le contexte de l'aiguë, dans le contexte du chronique, c'est-à-dire une douleur qui dure depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, on pensera plutôt à un cancer de tissu bulle.

(25:44 - 26:17)

Le cancer de tissu bulle, c'est une pathologie qui survient le plus fréquemment chez des

patients entre 25 et 35 ans. La tranche 25-35 ans est la plus intéressée par le cancer de tissu bulle. C'est généralement un petit nodule testiculaire qui augmente dure, légèrement sensible à la palpation et qui augmente de volume de façon progressive.

(26:18 - 27:26)

La deuxième étiologie, ce sont les varicocèles. Les varicocèles, ce qui sont une dilatation, une variqueuse des veines du cordon spermatique qui sont secondaires à une insuffisance de petits valvules au niveau des veines spermatiques causant par conséquent le reflux du sang de la veine cave ou de la veine rénale jusqu'au niveau des veines spermatiques. Mais le plus souvent, c'est qu'une varicocèle se situe à gauche et donc généralement et absolument, il y a un reflux important de la veine rénale gauche au niveau des veines spermatiques qui est secondaire à cette insuffisance des petits valvules qui prévient le reflux veineux et par conséquent, on se trouve avec des veines qui sont très dilatées et purgescentes au niveau des cordons spermatiques et du scrotum.

(27:26 - 28:25)

La troisième étiologie de la douleur chronique, ce sont les idrosselles. L'idrosselle, c'est une présence de liquide au niveau de la vaginale testiculaire. La vaginale testiculaire a en fait deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet parétal et entre ces deux feuillets-là, il se trouve parfois qu'il y a un liquide qui se forme, soit un liquide péritonial avec la persistance du canal péritonial vaginal qui se draine au niveau de cette région-là ou bien secondaire généralement à une inflammation testiculaire qui a eu lieu depuis plusieurs mois ou des années et qui a donc donné ce tableau de l'idrosselle.

(28:28 - 29:44)

Alors, cette torsion peut-être soit supravaginale, c'est le cas chez le nouveau-né généralement ou bien une torsion intravaginale, généralement chez l'adolescent. Les prostatites, les prostatites sont des douleurs qui peuvent être aiguës ou chroniques, aiguës généralement des troubles mixionnels associés à des troubles mixionnels chez l'homme et par conséquent des troubles mixionnels que ce soit une polacurie, urgenturie, disurie associées chez un homme, j'ai entendu, associées à une douleur périnéale dans un contexte fébrile, ça oriente automatiquement vers un tableau d'une prostatite aiguë. Et cela, il se revient depuis quelques heures, bien qu'il y ait toujours une prostatite aiguë.

(29:44 - 30:11)

Il peut même donner une complication, c'est-à-dire la rétention aiguë d'urine. La prostatite est tellement inflammatoire, infectée, qu'il peut causer un obstacle à l'évacuation, à la vidange des urines et causer une rétention aiguë. Cette prostatite, pendant le cours, peut devenir chronique.

(30:12 - 30:44)

Alors la douleur, le siège périnéal, on parle de prostatodynie, c'est-à-dire une douleur d'origine prostatique, irradiant au niveau de la verge et de la face interne des glisses. Les signes associés, comme on a dit, les signes urinaires, brûlure mictionnelle, pollacurie, urgencye, dysurie, voire même rétention aiguë d'urine. Et n'oubliez pas que la prostate présente un rapport très important.

(30:46 - 31:10)

En arrière, c'est la face interne du rectum. Et donc, en présence d'une prostate inflammatoire, il y aura une irritation rectale, et pas conséquente pour avoir des ténèbres et de pauvres besoins associés. Généralement, il s'agit d'une affection prostatiquement spécifique.

(31:12 - 31:26)

Les douleurs de la verge sont essentiellement de deux types. Alors le premier, ils sont en rapport avec une pathologie infectieuse et inflammatoire. Ils sont les urétrites.

(31:26 - 32:05)

C'est une douleur urétrale, à type de picotements, et survenant surtout au cours de la miction. Le patient vous dit qu'il urine avec une grande gêne, avec des brûlures très importantes au niveau du canal de l'urètre, avec une sensation d'uriner des lames de rasoir. Les causes sont essentiellement les infections sexuellement transmissibles.

(32:07 - 32:36)

C'est à ces caractéristiques que le patient présente un écoulement pénétral, qui peut être important ou bien moins important avec une simple goutte matinale. Au niveau du méat urétral. La deuxième cause des douleurs de la verge, ce sont les traumatismes de la verge, causant surtout des fractures des corps caverneux.

(32:38 - 33:19)

Et c'est une douleur qui est atroce, qui est très importante, avec une sensation de craquement lors du traumatisme, et généralement c'est un traumatisme qui survient sur une verge en érection. Alors en conclusion, les douleurs en neurologie sont des signes très très importants, qu'il faudra savoir analyser pour s'orienter vers l'étiologie correcte. La douleur en neurologie peut prendre des formes variables, comme vous avez vu.

(33:20 - 33:38)

Il faudra savoir détailler la signologie de la douleur, pour mieux orienter la demande des examens complémentaires, qui est une chose très très importante, afin d'en détailler et d'aboutir au diagnostic correct.